



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN TRIWULAN I
KOMITE PPRA
BULAN JANUARI - MARET
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya penyusunan Laporan Triwulan I Pengendalian Pencegahan Resistensi Antimikroba tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu sehingga dapat dilaporkan kepada Dewan Pengawas dan Pemilik Rumah Sakit Prima Husada (PT. Disa Prima Medika).

Pengendalian Pencegahan Resistensi Antimikroba dilakukan berdasarkan tersedianya data audit penggunaan antibiotik. Data yang tersedia yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Kedua data tersebut saling berkesinambungan untuk dapat menilai apakah penggunaan antibiotik Rumah Sakit sudah tergolong rasional atau tidak. Hasil audit kuantitatif dan kualitatif dapat dijadikan penilaian terhadap seluruh SMF terkait pemberian antibiotik didasarkan pada PPAB (Panduan Penggunaan Antibiotik).

Dengan tersusunnya Laporan Pengendalian Pencegahan Resistensi Antimikroba ini, kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah membantu terselesaikannya laporan ini sehingga dapat dipergunakan untuk pendekatan sistemik dalam hal aplikasi proses dan pengetahuan yang seragam dalam melaksanakan semua kegiatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit.

Penyusun

I. SDM

Jumlah SDM bulan ini:

Jabatan	Jumlah SDM			Ket.
	Standar	Januari – Maret	Kebutuhan	
Ketua PPRA	1	1	0	
Sekretaris	1	1	0	
Anggota	31	31	0	

II. Pemenuhan kualifikasi SDM:

Jabatan	Nama	Pendidikan		Pelatihan	Keterangan
		Standar	Kondisi saat ini		
Ketua	dr. Dicky Faturrachman, Sp. A., M. Biomed.	S1	Sp 1 pediatrik	Pelatihan PPRA eksternal	Belum terlaksana
Sekretaris	apt. Rifdah Bunga K S.Farm.	S1	Apoteker	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
Anggota	dr. Ari Putriani, Sp.PK	S1	Dokter Patologi Klinik	Pelatihan PPRA eksternal	Terlaksana
	dr. Arief Heru Wicaksono, Sp.An	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	dr. Ardhi Bustami, Sp. PD	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	dr. Adhya Aji Pratama, Sp. PD	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Belum Terlaksana
	dr. Antonius Setiadi, Sp. B	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	dr. Iwan Donosepoetr o, Sp. B.FINACS	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana

dr. Sigit Wahyu Jatmiko, Sp. BP-RE	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
dr. Heriyatmo, Sp.Pd	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
dr. Ira Setya, Sp. JP	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
dr. Dewi Maharani, Sp. S	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
dr. Titok, Sp. M	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
dr. Aida M., Sp. OG	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
dr. Andy, Sp. P	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
dr. Pradana Nurhadi, Sp. U	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
dr. Arianto, Sp. OT	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
dr. Miftakhul Huda, Sp. KJ	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
drg. Bhakti Prasetyo D, Sp. Ort	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
dr. Nimim , Sp. KK	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
dr. Naufal Fraid Dwi Rendragraha	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
dr. Rino R.	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana

	dr. Nur Mazidah	S1	Dokter	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	apt. Yuanita Eka L, S.Farm	S1	Apoteker	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	apt. Asharul Fahrizi, S.Farm	S1	Apoteker	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	apt. Ica Anindya Pangestika, S.Farm	S1	Apoteker	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	apt. Guspa Gayatri A, S.Farm	S1	Apoteker	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	apt. Fadilah Maulana Ihram A, S.Farm	S1	Apoteker	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	ns. Very Susanto, S. Kep	S1	S1 Ners	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	ns. Siti Durotul Ibadiyah, S. Kep	S1	S1 Ners	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	Puput Sekar Nari Ratih, Amd. Kep	S1/D3	Bidan	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	Sherly Rosita, Amd. Kep.	S1/D3	Perawat	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana
	Trikaya Inggar Yuniar, Amd. Kep	S1/D3	Perawat	<i>In house training</i> tahun 2023	Terlaksana

III. PROGRAM KERJA DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN

No	Kegiatan Pokok	Hasil	Ket.
1	Pembuatan Pedoman Penggunaan Antibiotika RS	Tidak ada pembaharuan Pedoman Penggunaan Antibiotik (PPAB)	Pedoman penggunaan antibiotik yang ada masih relevan untuk digunakan
2	Sosialisasi PPRA	Meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan tentang PPRA tahun 2025	
3	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Antibiotika	Rapat untuk membahas tentang pengumpulan data penggunaan antibiotika di RS Prima Husada	Laporan triwulan

IV. FASILITAS

No	Kegiatan Pokok	Ket.
1	Ruang Komite PPRA	Mengajukan ke pihak manajemen, belum ada realisasi

V. INDIKATOR MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN PPRA

No	Indikator Mutu	Standar
1	Surveilans penggunaan antibiotika secara keseluruhan di RS Prima Husada	-
2	Audit penggunaan antibiotika secara kualitatif (Gyssens)	≥50%
3	Surveilans pola kuman dan kepekaan antibiotika tahun 2025	-
4	Audit penggunaan antibiotik secara kuantitatif	-

VI. PENCAPAIAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN PPRA TRIWULAN I

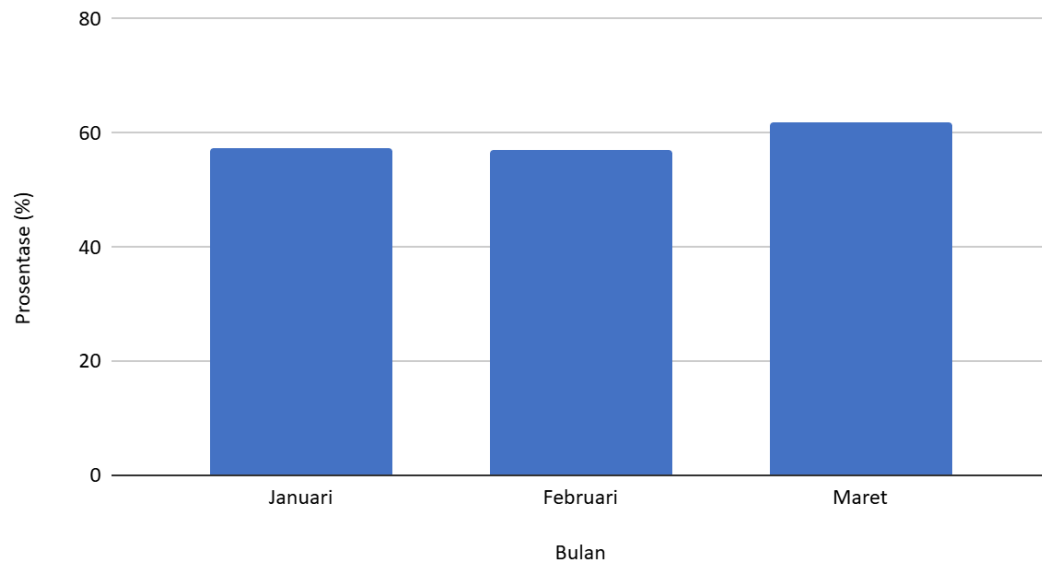
1. Surveilans penggunaan antibiotika secara keseluruhan di RS Prima Husada

a. Tabel Surveilans penggunaan antibiotik secara keseluruhan di RS Prima Husada

No	Bulan	Prosentase (%)
1	Januari	57,22
2	Februari	57,06
3	Maret	62,01

b. Grafik surveilans penggunaan antibiotik secara keseluruhan di RS Prima Husada

Suvrilens Penggunaan Antibiotik



c. Analisa surveilans penggunaan antibiotik secara keseluruhan di RS Prima Husada

- Pengambilan data diambil dari SIMRS
- Penggunaan antibiotik pada bulan Januari sebesar 57,22 %, pada bulan Februari sebesar 57,06 %, dan pada bulan Maret sebesar 62,01 %. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan antibiotik lebih dari target (>50%).

d. Rencana tindak lanjut

- Dilakukan sosialisasi masiv terkait penggunaan antibiotik bijak dan rasional terhadap DPJP.
- Dukungan manajemen melalui komite medis untuk melakukan supervisi terkait penggunaan antibiotik.

2. Audit penggunaan antibiotika secara kualitatif (Gyssens)

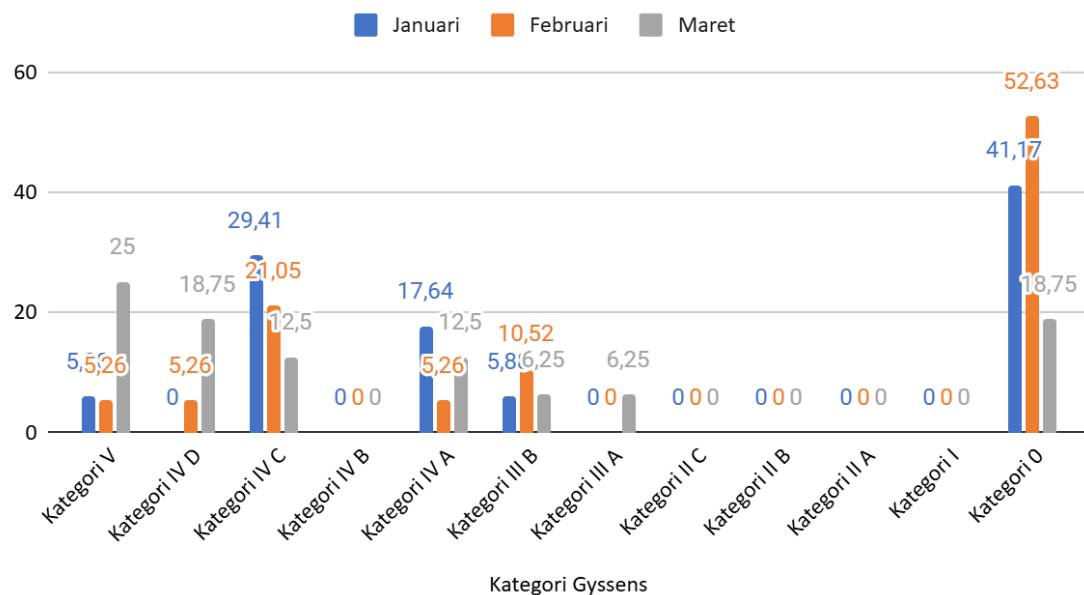
a. SMF Bedah

- Tabel audit penggunaan antibiotika SMF Bedah secara kualitatif (Gyssens)

NO	Kategori Gyssens	Jumlah (%)		
		Januari	Februari	Maret
1.	Kategori V	5,88	5,26	25
2.	Kategori IV D	0	5,26	18,75
3.	Kategori IV C	29,41	21,07	12,5
4.	Kategori IV B	0	0	0
5.	Kategori IV A	17,66	5,26	12,5
6.	Kategori III B	5,88	10,52	6,25
7.	Kategori III A	0	0	6,25
8.	Kategori II C	0	0	0
9.	Kategori II B	0	0	0
10.	Kategori II A	0	0	0
11.	Kategori I	0	0	0
12.	Kategori 0	41,17	52,63	18,75
Total		100	100	100

- Grafik audit penggunaan antibiotik SMF Bedah secara kualitatif (Gyssens)

SMF BEDAH



- Analisa penggunaan antibiotika secara kualitatif (Gyssens)

- Pada triwulan I terdapat kategori 0 yaitu penggunaan antibiotik tepat dan rasional. Presentase kategori 0 tertinggi pada SMF Bedah terdapat pada bulan Februari sebesar 52,63 %.
- Kategori III A terdapat pada SMF Bedah dengan prosentase sebesar 6,25 % yang

-
- menunjukkan durasi pemberian antibiotik terlalu lama.
3. Kategori III B terdapat pada SMF Bedah. Prosentase tertinggi terdapat pada bulan Februari sebesar 10,52 % yang menunjukkan durasi pemberian antibiotik terlalu singkat.
 4. Kategori IV A tertinggi pada SMF Bedah dengan prosentase sebesar 17,64 % dibulan Januari yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena ada antibiotik lain yang lebih efektif.
 5. Kategori IV C paling tinggi terdapat pada SMF Bedah sebesar 29,41 % dibulan Januari yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena terdapat antibiotik lain yang lebih murah.
 6. Kategori IV D paling tinggi terdapat pada SMF Bedah sebesar 18,75 % dibulan Maret yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena ada antibiotik lain yang lebih sempit spektrumnya.
 7. Kategori V terdapat pada SMF Bedah sebesar 25 % dibulan Maret yang menunjukkan adanya pemberian antibiotik namun tidak ada indikasi.
- Rencana tindak lanjut
 - Untuk SMF bedah pada bulan Februari, persentase Gyssens kategori 0 sudah memenuhi standar, maka perlu dipertahankan dan ditingkatkan
 - Untuk persentase Gyssens kategori V yaitu pemberian antibiotik tanpa indikasi masih termasuk cukup tinggi sehingga perlu dukungan manajemen melalui komite medis untuk melakukan supervisi dan sosialisasi terkait penggunaan antibiotik yang bijak dan rasional.

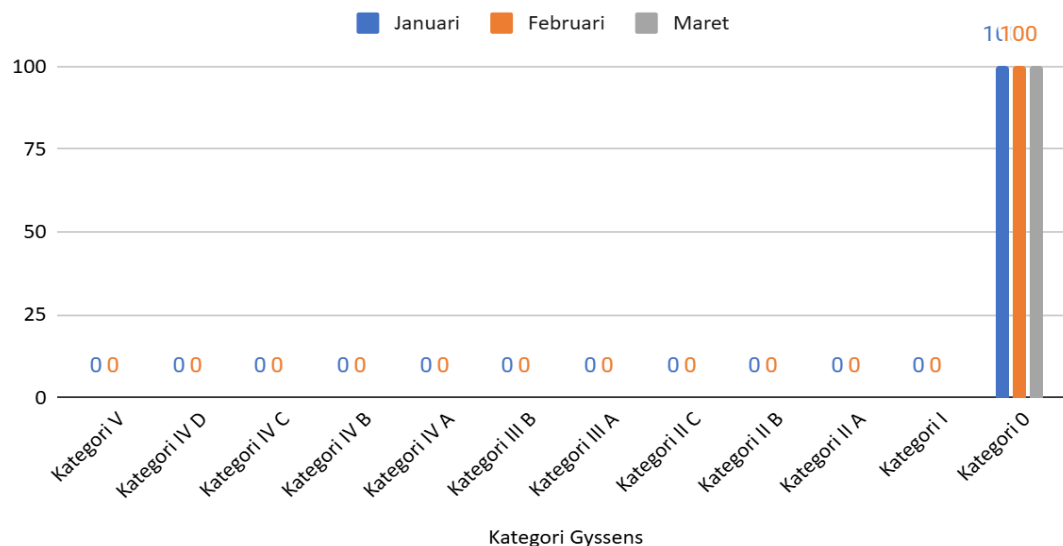
b. SMF Obgyn

- Tabel audit penggunaan antibiotika SMF Obgyn secara kualitatif (Gyssens)

NO	Kategori Gyssens	Jumlah (%)		
		Januari	Februari	Maret
1.	Kategori V	0	0	0
2.	Kategori IV D	0	0	0
3.	Kategori IV C	0	0	0
4.	Kategori IV B	0	0	0
5.	Kategori IV A	0	0	0
6.	Kategori III B	0	0	0
7.	Kategori III A	0	0	0
8.	Kategori II C	0	0	0
9.	Kategori II B	0	0	0
10.	Kategori II A	0	0	0
11.	Kategori I	0	0	0
12.	Kategori 0	100	100	100
Total		100	100	100

- Grafik audit penggunaan antibiotik SMF Obgyn secara kualitatif (Gyssens)

SMF OBGYN



- Analisa penggunaan antibiotik secara kualitatif (Gyssens)

Pada SMF Obgyn hanya terdapat kategori 0 yang menunjukkan penggunaan antibiotik tepat dan rasional. Presentase kategori 0 pada SMF Obgyn yaitu 100 % disetiap bulannya.

- Rencana tindak lanjut

Pada SMF Obgyn, persentase Gyssens kategori 0 sudah mencapai 100%, maka

perlu dipertahankan.

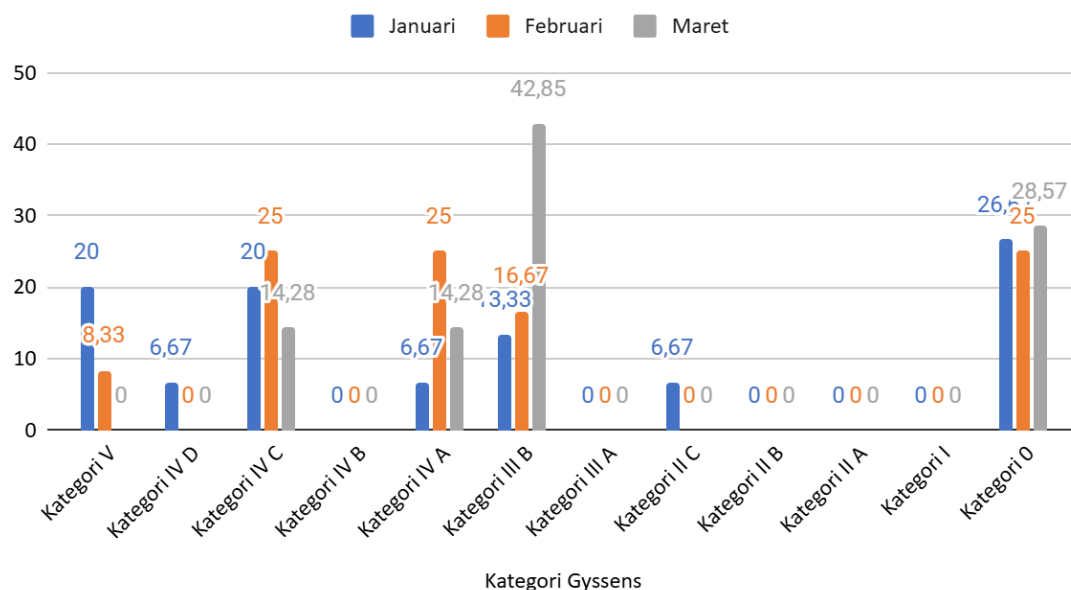
c. SMF IPD, Paru, Jantung dan Syaraf

- Tabel audit penggunaan antibiotika SMF IPD, Paru, Jantung dan Syaraf secara kualitatif (Gyssens)

NO	Kategori Gyssens	Jumlah (%)		
		Januari	Februari	Maret
1.	Kategori V	20	8,33	0
2.	Kategori IV D	6,67	0	0
3.	Kategori IV C	20	25	14,28
4.	Kategori IV B	0	0	0
5.	Kategori IV A	6,67	25	14,28
6.	Kategori III B	13,33	16,67	42,85
7.	Kategori III A	0	0	0
8.	Kategori II C	6,67	0	0
9.	Kategori II B	0	0	0
10.	Kategori II A	0	0	0
11.	Kategori I	0	0	0
12.	Kategori 0	26,67	25	28,57
Total		100	100	100

- Grafik audit antibiotik SMF IPD, Jantung, Paru, Syaraf secara kualitatif (Gyssens)

SMF IPD, PARU, SYARAF, JANTUNG



- Analisa penggunaan antibiotika secara kualitatif (Gyssens)
 - Pada triwulan I terdapat kategori 0 yaitu penggunaan antibiotik tepat dan rasional, namun dari ketiga bulan tersebut, persentasenya masih belum memenuhi standar.
 - Pada triwulan I terdapat Kategori II C sebesar 6,67% dibulan Januari yang

menunjukkan pemberian antibiotik tidak tepat rute pemberiannya.

3. Kategori III B terdapat pada SMF IPD, Jantung, Paru, Syaraf. Prosentase tertinggi terdapat pada bulan Maret sebesar 42,85 % yang menunjukkan durasi pemberian antibiotik terlalu singkat
 4. Kategori IV A tertinggi pada SMF IPD, Jantung, Paru, Syaraf. Prosentase tertinggi sebesar 25 % dibulan Februari yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena ada antibiotik lain yang lebih efektif.
 5. Kategori IV D terdapat pada SMF IPD, Jantung, Paru, Syaraf sebesar 6,67 % dibulan Januari yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena ada antibiotik lain yang lebih sempit spektrumnya.
 6. Kategori V terdapat pada SMF IPD, Jantung, Paru, Syaraf sebesar 20 % dibulan Januari yang menunjukkan adanya pemberian antibiotik namun tidak ada indikasi.
- Rencana tindak lanjut

Untuk SMF IPD, Jantung, Paru, Syaraf, persentase Gyssens kategori V (Pemberian antibiotik tanpa indikasi) masih termasuk cukup tinggi. Begitu juga dengan kategori Gyssens kategori 0 (Pemberian antibiotik tepat dan rasional) yang persentasenya masih belum memenuhi standar, sehingga perlu dukungan manajemen melalui komite medis untuk melakukan supervisi dan sosialisasi terkait penggunaan antibiotik yang bijak dan rasional.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan penggunaan antibiotik rasional, maka perlu dilakukan PDSA sebagai berikut.

PLAN	DO	STUDY	ACTION
1. Meningkatkan persepsian antibiotik rasional >50%. 2. Meningkatkan kepatuhan DPJP terhadap PPAB dengan cara: • Melakukan sosialisasi secara rutin dan terus-menerus • Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan antibiotik rasional oleh tim PPRA.	1. Mengamati pelanggaran DPJP terhadap PPAB 2. Menelusuri penyebab terjadinya pelanggaran tersebut dengan pendekatan secara personal.	DPJP diajak berdiskusi untuk membentuk PPAB yang sesuai dengan PPK yang betul-betul disepakati.	Meningkatkan kepatuhan DPJP terhadap PPAB dengan cara: 1. melakukan sosialisasi secara rutin dan terus menerus

3. Surveilans pola kuman dan kepekaan antibiotika tahun 2025

Surveilans pola kuman dan kepekaan antibiotika tahun 2025 masih dalam proses pengajuan pembuatan pola kuman.

4. Audit Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif Triwulan I Tahun 2025

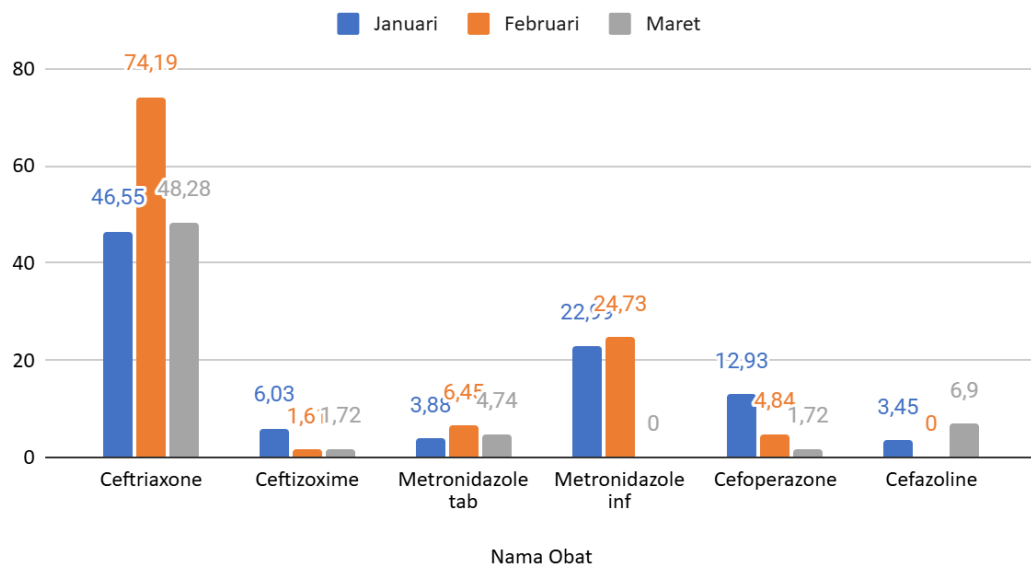
a. SMF Bedah

- Tabel perhitungan antibiotik pada SMF bedah secara kuantitatif

No	Nama obat	Bulan (DDD/100)		
		Januari	Februari	Maret
1.	Ceftriaxone	46,55	74,19	48,28
2.	Ceftizoxime	6,03	1,61	1,72
3.	Metronidazole tab	3,88	6,45	4,74
4.	Metronidazole inf	22,99	24,73	0
5.	Cefoperazone	12,93	4,84	1,72
6.	Cefazoline	3,45	0	6,90

- Grafik penggunaan antibiotik pada SMF bedah secara kuantitatif

DDD/100 HARI RAWAT INAP SMF BEDAH



- Analisa audit penggunaan antibiotik secara kuantitatif pada SMF bedah

Penggunaan antibiotik pada triwulan I tahun 2025 oleh SMF Bedah terdiri dari Ceftriaxone, Ceftizoxime, Metronidazole po, Metronidazole inf, Cefoperazone, dan Cefazoline. Antibiotik yang paling banyak digunakan oleh SMF bedah adalah antibiotik Cefazoline. Nilai tertinggi terdapat di bulan Februari sebesar 74,19 DDD/100 hari rawat inap. Hasil tersebut dapat dikaitkan dengan pemberian Ceftriaxone sebagai terapi empiris pada kebanyakan diagnosis infeksi di RS Prima Husada malang.

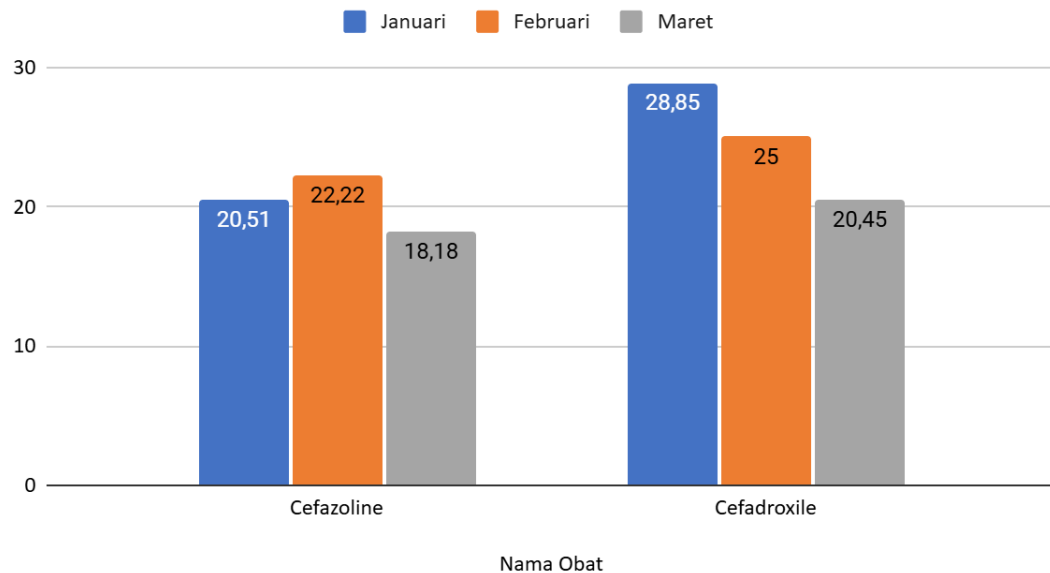
b. SMF Obygyn

- Tabel perhitungan antibiotik pada SMF obygn secara kuantitatif

No	Nama obat	Bulan (DDD/100)		
		Januari	Februari	Maret
1.	Cefazolin	20,51	22,22	18,18
2.	Cefadroxile	28,85	25	20,45

- Grafik penggunaan antibiotik pada SMF obygn

DDD/100 HARI RAWAT INAP SMF OBGYN



- Analisa audit penggunaan antibiotik secara kuantitatif pada SMF obygn

Penggunaan antibiotik pada SMF Obygn terdiri dari Cefazolin dan Cefadroxile. Antibiotik yang paling banyak di gunakan pada SMF Obygn adalah antibiotik Cefadroxile. Nilai DDD/100 tertinggi terdapat pada bulan Januari sebesar 28,85 DDD/100 hari rawat inap.

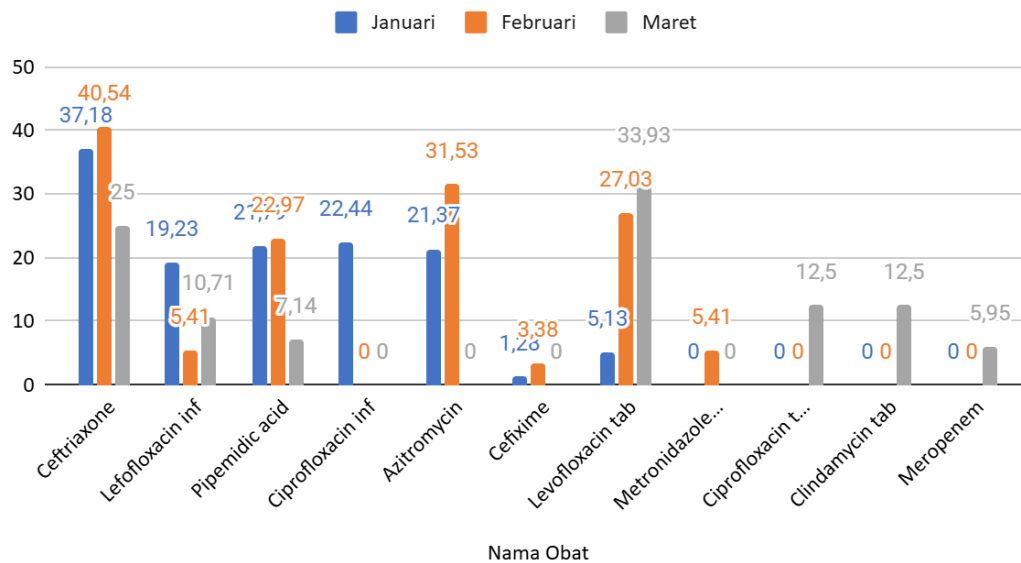
c. SMF IPD, Paru, Jantung dan Syaraf

- Tabel perhitungan antibiotik pada SMF IPD, Paru, Jantung dan Syaraf

No	Nama obat	Bulan (DDD/100)		
		Januari	Februari	Maret
1.	Ceftriaxone	37,18	40,54	25,00
2.	Lefofloxacin inf	19,23	5,41	10,71
3.	Pipemidic acid	21,79	22,97	7,14
4.	Ciprofloxacin inf	22,44	0	0
5.	Azitromycin	21,37	31,53	0
6.	Cefixime	1,28	3,38	0
7.	Levofloxacin tab	5,13	27,03	33,93
8.	Metronidazole inf	0	5,41	0
9.	Ciprofloxacin tab	0	0	12,50
10.	Clindamycin tab	0	0	12,50
11.	Meropenem	0	0	5,95

- Grafik penggunaan antibiotik pada SMF IPD, Paru, Syaraf, Jantung

DDD/100 HARI RAWAT INAP SMF IPD PARU, JANTUNG, SYARAF



- Analisa audit penggunaan antibiotik secara kuantitatif pada SMF IPD, Paru, Syaraf, Jantung

Penggunaan antibiotik oleh SMF IPD, Jantung, Paru dan Syaraf pada triwulan I terdiri dari 11 macam antibiotik. Antibiotik yang paling banyak di gunakan pada SMF IPD, Jantung, Paru dan Syaraf adalah antibiotik Ceftriaxone. Nilai tertinggi penggunaan Ceftriaxoen terdapat dibulan februari dengan nilai 40,54 DDD/100 hari rawat inap. Pada triwulan I terdapat penggunaan antibiotik kategori reserve yaitu Meropenem. Nilai DDD/100 dari antibiotik meropenem sebesar 5,95.

VII. KESIMPULAN

1. Surveilans penggunaan antibiotika secara keseluruhan di RS Prima Husada pada triwulan I tahun 2025 paling banyak terjadi pada bulan maret yakni sebesar 62.01 %
2. Penggunaan antibiotik tepat dan rasional yang memenuhi target pada setiap bulan dalam pelaporan triwulan I hanya pada SMF Obgyn. Untuk SMF Bedah penggunaan antibiotik tepat dan rasional yang memenuhi target hanya di bulan Februari.
3. Surveilans pola kuman dan kepekaan antibiotik 2025 masih dalam proses pengajuan pembuatan pola kuman
4. Penggunaan antibiotik terbanyak oleh SMF Bedah dan SMF IPD, Jsantung, Paru, Syaraf pada triwulan I tahun 2025 adalah antibiotik ceftriaxone sebesar 56,74; 35.10 DDD/100 hari rawat inap. Sedangkan pada SMF Obgyn antibiotik yang paling banyak di gunakan adalah Cefadroxile dengan nilai 25.00 DDD/100 hari rawat inap.

Malang, 02 April 2025

Penyusun,

Ketua Komite PPRA



dr. Dicky Faturrachman, Sp. A., M. Biomed.

Mengetahui,

Direktur RS Prima Husada



dr. Nur Mazidah